

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

Esta guía reúne los productos Peptigene en la categoría **hormona de crecimiento y recomposición corporal** (*secretagogos*, *ghrh*, *igf-1* y *gh*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los productos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico.

HORMONA DE CRECIMIENTO Y RECOMPOSICIÓN CORPORAL · Secretagogos, GHRH, IGF-1 y GH

CJC-1295 (No DAC) · Análogo de GHRH · acción corta

Presentaciones: 10 mg

Qué es. Análogo de GHRH sin DAC, de acción corta, que se combina con un secretagogo para pulsos de GH más fisiológicos.

Cómo funciona. Estimula a la hipófisis a liberar GH; al no tener DAC, respeta el patrón pulsátil natural.

Beneficios

- Mayor síntesis proteica y recuperación.
- Apoya la pérdida de grasa.
- Mejora del sueño y la piel.

Dosis habitual	100 mcg por dosis, 1–2/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos, junto a un secretagogo, bajo supervisión.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

CJC-1295 + Ipamorelina · GHRH + secretagogo · sinergia GH

Presentaciones: 10 mg

Qué es. Combinación clásica de un análogo de GHRH con un secretagogo selectivo para maximizar la GH natural.

Cómo funciona. CJC-1295 eleva la GH basal e ipamorelina añade pulsos, sin elevar de forma marcada cortisol ni prolactina.

Beneficios

- Recuperación y sueño profundo.
- Recomposición corporal.
- Mejora de la piel.

Dosis habitual	100 mcg + 200–300 mcg por dosis, 1–2/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	1 dosis nocturna	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos enfocados en recuperación y composición corporal.

Tesamorelina · Análogo de GHRH · grasa visceral

Presentaciones: 5 / 10 mg

Qué es. Análogo de GHRH con uso clínico aprobado para reducir grasa visceral.

Cómo funciona. Induce la liberación pulsátil de GH y la elevación del IGF-1.

Beneficios

- Reducción notable de grasa visceral.
- Apoya la recomposición corporal.
- Posible mejora cognitiva y lipídica.

Dosis habitual	1–2 mg/día (noche)	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses
Dosis mínima	1 mg/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Cáncer activo, embarazo, disfunción hipofisaria; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con exceso de grasa visceral, previa valoración.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

IGF-1 LR3 · Factor de crecimiento tipo insulina · anabólico potente

Presentaciones: 1 mg

Qué es. Variante de larga acción del IGF-1, muy anabólica, con vida media prolongada.

Cómo funciona. Activa los receptores de IGF-1 estimulando hiperplasia e hipertrofia muscular y la captación de nutrientes.

Beneficios

- Crecimiento muscular (hiperplasia).
- Mejor recuperación.
- Mayor captación de nutrientes.

Dosis habitual	20–50 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 4–6 sem
Dosis mínima	20 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo (fuerte estímulo de crecimiento), riesgo de hipoglucemia, embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Usuarios avanzados en recomposición, con control de glucosa; no apto con cáncer activo.

HGH (Somatropina) · Hormona de crecimiento recombinante

Presentaciones: según presentación (UI)

Qué es. Versión recombinante de la hormona de crecimiento humana; el estándar del eje GH.

Cómo funciona. Aporta GH directamente, elevando el IGF-1 y activando síntesis proteica, lipólisis y regeneración.

Beneficios

- Pérdida de grasa y aumento de masa magra.
- Recuperación, piel y calidad del sueño.
- Densidad ósea y bienestar general.

Dosis habitual	1–4 UI/día	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses
Dosis mínima	1 UI/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Cáncer activo, diabetes/retinopatía, síndrome del túnel carpiano, embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con deficiencia de GH o enfoque de recomposición, con control médico y analítico.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

AOD-9604 · Fragmento de GH · pérdida de grasa

Presentaciones: 10 mg

Qué es. Fragmento modificado de la hormona de crecimiento (176-191) orientado a la lipólisis.

Cómo funciona. Estimula la degradación de grasa sin los efectos de la GH sobre glucosa o crecimiento.

Beneficios

- Favorece la pérdida de grasa localizada.
- No afecta la glucemia ni el IGF-1.
- Buen perfil de tolerancia.

Dosis habitual	300 mcg/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	300 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Evidencia clínica limitada; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en pérdida de grasa; experimental.

HCG (Gonadotropina coriónica) · Gonadotropina · testosterona y fertilidad

Presentaciones: 5000 UI

Qué es. Hormona que imita a la LH, usada para estimular la producción de testosterona y la fertilidad.

Cómo funciona. Actúa sobre las células de Leydig testiculares (y el ovario), estimulando la producción de testosterona u óvulos.

Beneficios

- Eleva la testosterona endógena.
- Preserva el tamaño y la función testicular.
- Apoya la fertilidad; útil en PCT.

Dosis habitual	500–1500 UI, 2–3 veces/sem	Duración sugerida	Según objetivo o ciclo
Dosis mínima	500 UI	Vía	Subcutánea o intramuscular

Contraindicaciones. Cáncer hormonodependiente (próstata/mama), pubertad precoz, embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos en manejo hormonal o de fertilidad, con valoración; no apto con cáncer hormonodependiente.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**